บทบาท อสม. เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อสม. อาสาด้วยใจ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีบทบาทที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย การสื่อสารข่าวสาธารณสุข การแนะนำเผยแพร่ความรู้ ประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่างๆ อสม.จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน การที่เป็นผู้ทำงานด้วยความเสียสละเต็มใจช่วยเหลือชุมชน เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาชุมชน ช่วยดูแลให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี จึงกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า อสม. คือผู้ที่ทำงานเพื่อสังคม ด้วยหัวใจที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริง

ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต

เมื่อกล่าวถึงสุขภาพจิต คนส่วนใหญ่อาจเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของโรคจิต คนบ้า หรือคนปัญญาอ่อนเท่านั้น ซึ่งแท้จริงแล้วสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนและอยู่ในวิถีชีวิตของเรา ทุกคน เพราะสุขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตใจที่ดีและมีสมรรถภาพในเรื่องดังนี้

1. การรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุข คือ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถสร้างไมตรีกับผู้อื่นและรักษาสัมพันธภาพ ที่ดีกับคนอื่น ๆ ได้ยาวนาน
2. การรู้จักปรับตัว คือ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. การรู้จักปรับใจ คือ การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง รู้จักประคับประคองจิตใจในยามที่ประสบปัญหาและรู้จักหาความสุขในทางที่เหมาะสม

บทบาทของ อสม.ในการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนด้วยหลักการ 3 ส.

ในการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชน อสม.เป็นผู้มีบทบาทและพลังอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คนในชุมชนของตนมีสุขภาพจิตดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทำให้ชุมชนตนเองเป็นชุมชนสุขภาพจิตดี ดังนั้นการทำงานจึงควรมีบทบาทสำคัญดังนี้

“สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง”

บทบาท อสม. ในการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนด้วยหลักการ 3 ส.

1. สอดส่อง มองหา (Look)

การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยการมองหา สังเกต และเข้าถึงผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เช่น กลุ่มวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม กลุ่มวัยทำงานที่มีภาวะเครียด ซึมเศร้า กลุ่มวัยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นต้น





2. ใส่ใจรับฟัง (Listen)

การดูแลด้านจิตใจคนในชุมชน ได้แก่ การบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต ซึ่งการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา เช่น รับฟัง ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเตือนใจแก่คนที่ทุกข์ใจ ปลอบโยนให้กำลังใจ เยี่ยมเยียนถามไถ่อาการ ส่วนการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการดูจิตใจตนเอง ครอบครัว ชุมชน อาจสื่อสาร ผ่านหอกระจายข่าวหรือวิทยุชุมชน



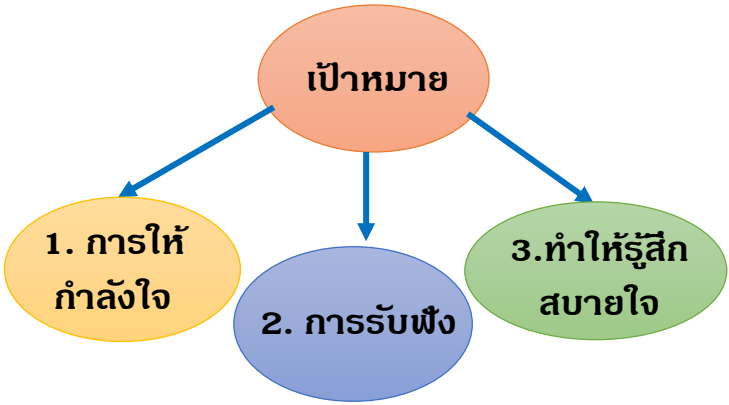
3. ส่งต่อเชื่อมโยง (Link)

การช่วยให้ได้รับการรักษาต่อเนื่อง โดยการพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติให้เห็นความสำคัญของการกินยาหรือปฏิบัติตัวตามหมอสั่ง การประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการส่งต่อ การติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การสื่อสารให้คนในชุมชนรับทราบ บริการสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 บริการ 24 ชั่วโมง

บทบาทการให้คำปรึกษาเบื้องต้น



การให้คำปรึกษา เป็นการพูดคุย เพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาให้สามารถระบายความทุกข์ใจ และคิดแก้ไขปัญหาของตนเอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม



5 หลักการให้คำปรึกษา



1. ถามเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นมาอย่างชัดเจน
2. ฟังเพื่อจับใจความและความรู้สึกของผู้ที่มาปรึกษา
3. ร่วมกันค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
4. ส่งเสริมให้คิดหาทางออกหลาย ๆ ทางเพื่อแก้ไขปัญหา
5. ให้ข้อคิดและกำลังใจให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปได้

ทักษะการพูด ฟัง สังเกต ให้กำลังใจ
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางจิตใจ

1. การตั้งคำถาม ที่เหมาะสมจะทำให้เรื่องที่เป็นปัญหาหรือสับสนมีความชัดเจนขึ้น ผู้ที่มีความทุกข์ใจจะสามารถเข้าใจเรื่องราวตนเองได้มากขึ้นด้วย



ประเภทคำถาม	ตัวอย่างคำถาม
1.1 ตั้งคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบขยายความ	“เรื่องราวเป็นมาอย่างไร” “เธอคิดว่าอย่างไร” “ที่เรื่องเป็นอย่างนี้ เธอรู้สึกอย่างไร”
1.2 ตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ	“ที่ว่าทุกข์ใจ ไม่สบายใจ หมายถึงคุณรู้สึกกังวลใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ใช่ไหม” “คุณคิดว่าคุณเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้หรือ” “สรุปว่าคุณตกลงใจที่จะทำตามที่เขาแนะนำใช่ไหม”



2.การสังเกต สีหน้า แววตา น้ำเสียง ว่ามีอารมณ์แบบไหน เช่น ดีใจ เศร้าหมอง ท้อแท้ หรือ โกรธ เป็นต้น

3.การฟังตั้งใจฟัง จดจ่อเรื่องที่ฟัง ฟังให้ตลอดเรื่องราว ไม่ขัด หรือเปลี่ยนเรื่อง**ฟังให้เข้าใจ**เรื่องราวความรู้สึกของผู้ที่ทุกข์ใจ

4.ท่าทีที่เหมาะสม มีท่าทีสงบ สุภาพ ไม่สับสน ใส่ใจ เต็มใจให้ความช่วยเหลือ

5. การให้กำลังใจและเสริมสร้างความภูมิใจให้สู้กับปัญหาต่อไป

ข้อควรคำนึงในการให้คำปรึกษา



ควรทำใจให้เป็นกลาง

เข้าใจในความรู้สึกและเห็นใจในความทุกข์

ต้องรักษาความลับ

ไม่คาดหวังว่าการช่วยเหลือของเราจะช่วยแก้ปัญหาได้







การให้คำปรึกษาไม่ใช่การแนะแนว การสั่งสอน การปลอบใจ แต่เป็นการช่วยให้ผู้มีปัญหาทุกข์ใจมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น

กรณีปัญหาที่เกินความรู้ความสามารถของ อสม. จำเป็นจะต้องส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน



ควรพูด

“ฉันเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกเธอนะ”

“ถ้าฉันเป็นเธอคงรู้สึกแบบเดียวกัน”

“ถ้าไม่สบายใจ เล่ามาได้นะ ยินดีรับฟัง”

“สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็เป็นบทเรียนที่ดี”



ไม่ควรพูด

“เอาแต่ร้องไห้ จะได้อะไรขึ้นมา”

“เรื่องของเธอมันเล็ก ฉันเจอมาเยอะกว่านี้”

“ฟังเรื่องของเธอแล้ว ฉันสงสารเธอจริงๆ”

“หักห้ามใจเสียเถิด นึกเสียว่าเป็นเวรกรรม”



พัฒนาการเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กแรกเกิด – 5 ปี

ช่วงอายุของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี เรียกว่า“ช่วงวัยทองของชีวิต”เด็กจะมีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายมากที่สุด ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดี ได้รับความอบอุ่นและถูกต้องตามวัย เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีมีความฉลาดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้เลี้ยงดูเด็กควรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ให้มากเป็นพิเศษ

เด็กไทยไอคิวต่ำ



ซ้ำมีโลหิตจาง



รูปร่างไม่สมส่วน



คุณรู้หรือไม่ เราสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
เพียงแค่คุณเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ

กิน กอด เล่น เล่า



7 ข้อที่ควรรู้ เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ควรให้เด็กกินไข่ 1-2 ฟอง/วัน และเด็กที่หย่านมแม่ ควรดื่มนมจืด 3 กล่องต่อวัน

ข้อ1 อาหาร (ธาตุเหล็ก และไอโอดีน)



ธาตุเหล็กและไอโอดีน มีผลอย่างมากต่อระดับสติปัญญาของเด็ก และเด็กควรได้รับในปริมาณที่เหมาะสมตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ ควรให้เด็กได้รับประทานไข่และนมทุกวัน เพราะเป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กและไอโอดีนสูง บำรุงสมอง

ข้อ 2 การให้เด็กได้ฝึกทำกิจกรรมด้วยตนเอง



การช่วยเหลือเด็กมากๆตลอดเวลาจะทำให้เด็กได้ฝึกทำกิจกรรมน้อยลง เสียโอกาสการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ

ข้อ 3 การเลือกของเล่นเด็กต้องเลือกให้เหมาะสมกับอายุ



ของเล่นมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นพัฒนาการ **แต่ควรงดเล่นเกมส์ในแท็บเล็ต** เพราะจะทำให้พัฒนาการช้าลง **เพราะ**ภาพที่เคลื่อนไหวเร็วเกินไป **ส่งผลให้มีปัญหาสมาธิสั้น** และ**ปัญหาด้านอารมณ์**

ข้อ 4 การตอบสนองของพ่อแม่ เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว



พ่อแม่อาจไม่รู้ตัวว่า **การหัวเราะชื่นชมในขณะที่เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนั้น ไม่เหมาะสม** เช่น เด็กตีผู้ใหญ่ หรือ พูดคำหยาบคาย หรือเล่นกับเพื่อนแบบรุนแรง ใช้ปืนไล่ยิงกัน ทั้งหมดนั้น**เป็นการส่งเสริม ให้เด็ก มีนิสัยก้าวร้าวและรุนแรงขึ้น**

ข้อ 5 การเล่านิทานสร้างสังคมได้ด้วยการอ่าน



พ่อแม่ที่อ่านนิทานให้เด็กฟังตั้งแต่แรกเกิด และอ่านเป็นประจำทุกวัน สามารถกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา จินตนาการ ทำให้เด็กมีสมาธิที่ดี และเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือให้กับเด็ก

ข้อ 6 การเลี้ยงลูกให้สูงดี สมส่วนและฟันดี



อาหารที่สำคัญ คือ ไข่และนม และออกกำลังกายโดยการกระโดด 2 ขา (กระโดดเชือก) อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน นอนให้ได้ 9 ถึง 11 ชั่วโมงต่อวัน จึงจะส่งผลให้เด็กสูงดีสมส่วน นอกจากนี้การดูแลฟันเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพเด็ก ควรแปรงฟันให้ถูกวิธี ใช้เวลาอย่างน้อย 2 -3 นาที แปรงฟันหลังกินอาหารทุกครั้งและก่อนนอน



น้องหม่อน (อายุ 3 ปี) โชคดีมากที่มีคุณยายให้ความสนใจอ่านหนังสือให้ฟังทุกๆ วัน ตั้งแต่อายุ 2 ปีครึ่ง น้องหม่อนมีพัฒนาการรวดเร็วทุกด้านพูดรู้เรื่องไม่เคยงอแง และไม่น่าเชื่อเลยว่า เวลาไปซื้อของเล่น หม่อนจะเลือกซื้อหนังสือ แทนที่จะซื้อของเล่นตามตลาดนัดต่างจากเด็กคนอื่นๆที่ไม่สนใจหนังสือเลย เพราะเด็กเหล่านั้นไม่เคยรู้ว่าหนังสือสร้างจินตนาการที่สนุกสนานได้มากกว่าของเล่น

ข้อ 7 หากพบว่าลูกมีพัฒนาการล่าช้าจงตระหนักไว้ว่า

เราสามารถกระตุ้นให้เด็ก กลับคืนเป็นปกติได้ด้วยตนเอง หรือให้ อสม. ร่วมกับผู้ปกครองช่วยกันกระตุ้นพัฒนาการเด็ก แต่หากฝึกกระตุ้นพัฒนาการแล้วภายใน 1 เดือน เด็กยังไม่สามารถทำได้ พ่อแม่ควรนำบุตรหลานของท่านมาพบหมอ เพื่อช่วยฝึกและกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการตามเกณฑ์อายุ อย่างเร่งด่วน

การปกปิดปัญหา หรือปกป้องเด็กโดยคิดว่าเด็กจะทำเองภายหลัง โดยไม่ใส่ใจกับช่วงอายุที่ควรทำได้อาจเป็นการทำร้ายลูกของท่าน โดยไม่รู้ตัว

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า... เด็กมีพัฒนาการล่าช้า

โดยใช้แบบคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

แบบคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ตามช่วงอายุเด็ก) โดย อสม.

อายุ 9 เดือน (หมายถึง อายุที่เต็มเดือนและนับต่ออีก 29 วัน คือ 9 เดือน 29 วัน)

ด้านการเคลื่อนไหว	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา	ด้านการเข้าใจภาษา	ด้านการใช้ภาษา	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
1. ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 2. ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่องเรือนสูงระดับอก ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	3. หยิบก้อนไม้จากพื้น และถือไว้มือละชิ้น หรือถือก้อนไม้ 2 ก้อนเคาะกัน ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 4. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่น ๆ หยิบของขึ้นจากพื้น ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	5. ทำตามคำสั่งง่ายๆ เมื่อใช้ท่าทางประกอบ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	6. เด็กรู้จักการปฏิเสธด้วยการแสดงท่าทาง ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 7. เลียนเสียงคำพูดที่คุ้นเคยได้อย่างน้อย 1 เสียง เช่น หม่ำ จ๊ะ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	8.ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน
วิธีฝึกทักษะ **ตัวอย่างการฝึกลุกขึ้นนั่งจากท่านอน** 1. จัดเด็กในท่านอนคว่ำ จับเข่างอทั้ง 2 ข้าง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้างยันพื้น 2. กดที่สะโพกเด็ก เพื่อให้เด็กยันตัวลุกขึ้นมาอยู่ในท่านั่ง **กระตุ้นให้เด็กลุกขึ้นนั่ง เช่น ใช้ลูกบอลยางบีบกระตุ้น หรือตบมือ/ใช้ท่าทางเรียก** **ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๋งกริ๋งทำด้วยพลาสติก/ผ้าลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ทรายพันให้แน่น**	**ตัวอย่างการฝึกหยิบก้อนไม้** 1. นำวัตถุสีสดใดขนาดประมาณ 1 นิ้ว เช่น ก้อนไม้ 2 ก้อน (ใช้วัตถุเหมือนกัน 2 ชิ้น) 2. เคาะของเล่นกับโต๊ะทีละชิ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กหยิบ 3. ถ้าเด็กไม่หยิบช่วยจับมือเด็กให้หยิบ **วัสดุที่ใช้แทนได้:** กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม	**ตัวอย่างการฝึกโบกมือ** 1. เล่นกับเด็กโดยใช้คำสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อมกับทำท่าทางประกอบ 2. ถ้าเด็กไม่ทำ ให้จับมือทำและค่อยๆ ลดความช่วยเหลือลงโดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก เมื่อเริ่มตบมือเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลง เป็นบอกหรือสั่งให้ทำอย่างเดียว	**ตัวอย่างการฝึกปฏิเสธ** เมื่อเด็กรับประทานอาหารหรือขนมอิ่มแล้ว ถามเด็กว่า “กินอีกไหม” แล้วสั่นศีรษะพร้อมกับพูดว่า “ไม่เอา” ให้เด็กเลียนแบบตาม ทำเช่นนี้กับสถานการณ์อื่น ๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้น	**ตัวอย่างการฝึกใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้** 1. วางอาหารที่เด็กชอบและหยิบง่าย ขนาด 1 คำ เช่น ขนมปังกรอบ ตรงหน้าเด็ก 2. จับมือเด็กหยิบอาหารใส่ปาก แล้วปล่อยให้เด็กทำเองฝึกบ่อย ๆ จนสามารถหยิบอาหารกินได้เอง
เด็กอายุ 9 เดือน พบว่าการใช้นิ้วหยิบอาหารกินเองได้ด้วยตนเอง ทำไม่ค่อยได้ ผู้ปกครองจึงต้องใส่ใจ เพราะถ้าฝึกช้า จะมีผลให้เด็กในช่วงอายุต่อไป จะมีพัฒนาการด้านอื่น ๆ ช้าลงไปด้วย				

อายุ 18 เดือน (หมายถึง 1 ปี 6 เดือน 29 วัน)

ด้านการเคลื่อนไหว	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา	ด้านการเข้าใจภาษา	ด้านการใช้ภาษา	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
1. วิ่งได้ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 2. เดินถือลูกบอลไปได้ไกล 3 เมตร ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	3. เปิดหน้าหนังสือที่ทำด้วยกระดาษแข็งทีละแผ่นได้เอง ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 4. ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	5. เลือกวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง 3 ชนิด ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 6. ชี้ออวัยวะได้ 1 ส่วน ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	7. พูดเลียนคำที่เด่นหรือคำสุดท้ายของคำพูด ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 8. พูดเป็นคำ ๆ ได้ 4 คำ เรียกชื่อสิ่งของหรือทักทาย (เป็นคำอื่นที่ไม่ใช่ พ่อแม่ ชื่อของคนคุ้นเคยในบ้านหรือชื่อของสัตว์เลี้ยงในบ้าน) ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	9. สนใจ/มองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้ที่อยู่ไกลออกไปอย่างน้อย 3 เมตร ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 10. ดื่มน้ำจากแก้วโดยไม่หก ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน
วิธีฝึกทักษะ **ตัวอย่างการฝึกลุกขึ้นนั่งจากท่านอน** 1. ฝึกให้เด็กเดินโดยถือของมือเดียว 2. เมื่อเด็กทำได้แล้วให้พ่อแม่ ผู้ปกครองวางตะกร้าไว้ในระยะห่าง 3 เมตร แล้วถือของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยสองมือและเดินเอาของไปใส่ตะกร้าให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กทำตาม 3. ถ้าเด็กทำไม่ได้ ให้ขยับตะกร้าให้ใกล้ขึ้นและจับมือเด็กถือของช่วยพยุงหากเด็กยังทรงตัวได้ไม่ดี 4. เมื่อเด็กทรงตัวได้และถือของได้ด้วยตนเองให้เพิ่มระยะทางจนถึง 3 เมตร **ของเล่นที่ใช้แทนได้ :วัสดุในบ้าน เช่น ตุ๊กตา หมอน**	**ตัวอย่างการฝึกเปิดหน้าหนังสือ** 1. เปิดหนังสือทีละหน้าแล้วชี้ให้เด็กดูรูปภาพและปิดหนังสือ 2. บอกให้เด็กทำตาม 3. ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้ช่วยจับมือเด็กพลิกหน้าหนังสือละหน้า 4. เล่านิทานประกอบรูปภาพเพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก **หนังสือที่ใช้แทนได้ :**หนังสือเด็กที่ทำด้วยพลาสติก ผ้า หรือกระดาษหนา ๆ	**ตัวอย่างการฝึกเลือกวัตถุตามคำสั่ง** 1. เตรียมของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 2 ชนิด และบอกให้เด็กรู้จักชื่อวัตถุทีละชนิด 2. ถามเด็ก “...อยู่ไหน” โดยให้เด็กชี้หรือหยิบถ้าเด็กเลือกไม่ถูกต้องให้เลื่อนของเข้าไปใกล้ และจับมือเด็กชี้หรือหยิบ 3. เมื่อเด็กสามารถเลือกได้ถูกต้องเพิ่มของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้นเคยเป็น 3 ชนิด และถามเช่นเดิมจนเด็กชี้หรือหยิบได้ถูกต้องทั้ง 3 ชนิด 4. เพิ่มวัตถุชนิดอื่นที่เด็กสนใจชี้ให้เด็กดูแล้วพูดให้เด็กชี้ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ภาษาของเด็ก **วัสดุที่ใช้แทนได้:** ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย	**ตัวอย่างการฝึกพูดเลียนคำ** 1. พูดกับเด็กก่อนแล้วค่อยทำกริยานั้นให้เด็กดู เช่น เมื่อแต่งตัวเสร็จ พูดว่า “ไปกินข้าว” แล้วออกเสียง “กิน” หรือ “ข้าว” ให้เด็กฟัง แล้วจึงพาไป 2. สอนให้เด็กพูดตามความจริง เช่น - ขณะแต่งตัว เมื่อเด็กให้ความร่วมมือดีให้ชมเชยว่า “เด็ก”หรือ “ดี” ได้ - เมื่อแต่งตัวเสร็จ พูดว่า “ไปกินข้าว” รอให้เด็กออกเสียง “กิน” หรือ “ข้าว” ก่อนแล้วจึงพาไป 3. ถ้าเด็กไม่ออกเสียงพูดตาม ให้ซ้ำคำเด่นหรือคำสุดท้ายนั้นจนเด็กสามารถเลียนคำพูดสุดท้ายนั้นได้ 4. เมื่อเด็กพูดได้แล้ว ให้ความสนใจและพูดโต้ตอบกับเด็ก เปลี่ยนใช้คำอื่น ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ * ขณะกำลังดูหนังสือฝึกให้เด็กพูดคำต่าง ๆ ตามรูปภาพ เช่น “ปลา” “โต๊ะ” “แมว”	**ตัวอย่างการฝึกใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้** - ชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้เด็กมองตาม หากเด็กยังไม่มองให้ประคองหน้าเด็กให้หันมองตามแล้วค่อยชี้ของที่อยู่ไกลออกไป จนถึง 3 เมตร ตัวอย่างการฝึกดื่มน้ำ 1. ประคองมือเด็กให้ยกแก้วน้ำขึ้นดื่ม ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือจนเด็กสามารถถือแก้วน้ำยกขึ้นดื่ม โดยไม่หก 2. ฝึกเด็กดื่มนมและน้ำจากแก้ว (เลิกใช้ขวดนม) ขอที่ใช้แทนได้ : ขันน้ำ
เด็กอายุ 1 ปีครึ่ง ส่วนใหญ่ด้านที่ทำไม่ค่อยได้ มี 3 เรื่อง คือ รู้จักอวัยวะอย่างน้อย 1 ส่วน พูดได้อย่างน้อย 4 คำ และดื่มน้ำได้เอง				

อายุ 30เดือน (หมายถึง 2 ปี 6 เดือน 29 วัน)

ด้านการเคลื่อนไหว	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา	ด้านการเข้าใจภาษา	ด้านการใช้ภาษา	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
1. กระโดดข้ามเชือกบนพื้นไปข้างหน้าได้ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 2. ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	3. ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยม ลูกบาศก์เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 4. ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น ตามคำสั่ง (รู้จำนวนเท่ากับ 1) ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	5. สนใจฟังนิทานได้ นาน 5 นาที ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 6. วางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ “ข้างใต้” ตามคำสั่งได้ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	7. พูดติดต่อกัน 2 คำ อย่างมีความหมายโดยใช้คำกริยาได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	8. ร้องเพลงได้บางคำ หรือร้องเพลงคลอตามนำนอง ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 9. เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเองในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน
วิธีฝึกทักษะ **ตัวอย่างการฝึกกระโดดเชือก** 1. กระโดดอยู่กับที่ ให้เด็กดู 2. จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดดมาจากบันไดขั้นที่ติดกับพื้นหรือจากพื้นต่างระดับ 3. กระโดดข้ามเชือกให้เด็กดู 4. ยื่นหันหน้าเข้าหาเด็กโดยวางเชือกคั่นกลาง และจับมือเด็กพยุงไว้ดึงมือให้เด็กกระโดดข้ามเชือก ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กมั่นใจและสามารถกระโดดข้ามเชือกได้เอง 5. พ่อแม่ ผู้ปกครอง อสม. ควรระมัดระวังในระหว่างการกระโดด **วัสดุที่ใช้แทนได้:** ริบบิ้น เชือก ฟาง ใช้ไม้ขีดเส้นตรงบนพื้นดินหรือใช้ถ่านขีดเส้นตรงบนพื้น **ผ่าน:** เด็กสามารถกระโดดข้ามเชือกได้ โดยเท้าไม่ต้องลงพื้นพร้อมกัน	**ตัวอย่างการฝึกต่อก้อนไม้** 1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้ กล่องสบู่ วางต่อกันในแนวตั้งให้เด็กดู 2. กระตุ้นให้เด็กทำตาม 3. ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวางก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อย ๆ จนครบ 8 ชั้น 4. ทำซ้ำหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง หากเด็กทำได้แล้วให้ชมเชย **ตัวอย่างการฝึกยื่นวัตถุ 1 ชิ้น** 1. วางวัตถุชนิดเดียวกัน 3 ชิ้นตรงหน้าเด็ก เช่น ช้อน 3 คัน และพูดว่า “หยิบช้อนให้แม่ 1 คัน” 2. ถ้าเด็กหยิบให้เกิน 1 คัน ให้พูดว่า “พอแล้ว” หรือจับมือเด็กไว้เพื่อไม่ให้ส่งเพิ่ม	**ตัวอย่างการฝึกเลือกวัตถุตามคำสั่ง** 1.อ่านนิทานสั้น ๆ ให้เด็กฟังทุกวันด้วยน้ำเสียงที่สนุกสนาน 2. ให้เด็กดูรูปภาพ และแต่งเรื่องเล่าจากรูปภาพเพื่อให้เด็กสนใจ เช่น “กระต่ายน้อยมีขนสีขาวมีหูยาว ๆ กระโดดได้ไกล และวิ่งได้เร็ว” 3. ในระยะแรกใช้นิทานสั้น ๆ ที่ใช้เวลา 2-3 นาที ต่อเรื่องก่อน ต่อไปจึงเพิ่มความยาวของนิทานให้มากขึ้นจนใช้เวลาประมาณ 5 นาที **ตัวอย่างการฝึกวางวัตถุบน - ล่าง** 1. วางของเล่น เช่น บอล ไว้ที่ตำแหน่ง “ข้างบน” แล้วบอกเด็กว่า “บอลอยู่ข้างบนโต๊ะ” 2. สั่งให้เด็ก หยิบของเล่นอีกชิ้นหนึ่งมาวางไว้ข้างบนโต๊ะถ้าเด็กทำไม่ได้ ให้จับมือเด็กทำ 3. ทำซ้ำโดยเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง “ข้างใต้”	**ตัวอย่างการฝึกพูดติดต่อกัน** ฝึกให้เด็กพูดตามสถานการณ์จริง เช่น ขณะรับประทานอาหารถามเด็กว่า “หนูกำลังทำอะไร” รอให้เด็กตอบ “กินข้าว” หรือขณะอ่านหนังสือ ถามเกี่ยวกับรูปภาพในหนังสือ เช่น ชี้ไปที่รูปแมว แล้วถามว่า “แมว ทำอะไร” รอให้เด็กตอบ เช่น “แมววิ่ง” ถ้าเด็กตอบไม่ได้ช่วยตอบนำและถามซ้ำเพื่อให้เด็กตอบเองฝึกในสถานการณ์อื่น ๆ โดยเด็กต้องใช้วลี 2 คำขึ้นไป ที่ใช้คำกริยาได้ถูกต้อง เช่น ให้ตอบจากบัตรภาพคำกริยา ได้แก่ อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน เป็นต้น **ของเล่นที่ใช้แทนได้ :**ตุ๊กตาคน หรือตุ๊กตาสัตว์ที่มีอยู่ในบ้าน	**ตัวอย่างการฝึกรอ** 1. ผลัดกันเล่นกับเด็ก จนเด็กคุ้นเคยก่อน 2. ฝึกให้เด็กเล่นเป็นกลุ่มด้วยกันโดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองบอกเด็ก เช่น “..(ชื่อเด็ก)..” เอาห่วงใส่หลัก “แล้วรอก่อนนะ” 3. พ่อแม่ ผู้ปกครองบอกให้เด็กคนต่อไปเอาห่วงใส่หลัก ถ้าเด็กรอไม่ได้ให้เตือนทุกครั้งจนเด็กรอได้เอง 4. ฝึกเล่นเกมส์อย่างอื่น เช่น ร้องเพลง/นับเลขพร้อมกันก่อนแล้วค่อยกินขนม หรือในสถานการณ์อย่างอื่นที่ต้องมีการรอให้ถึงรอบของตนเองกับเด็ก เช่น พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าแถวรอจ่ายเงินเวลาซื้อของ วัสดุที่ใช้แทนได้ : ตะกร้าใส่ของ/กล่อง/จาน และของเล่นต่าง ๆ ที่มีในบ้าน
เด็กอายุ 2 ปีครึ่ง ส่วนมากมีปัญหาพัฒนาการ 2 เรื่อง คือ นั่งนิ่ง ๆ ฟังนิทานได้นานเกิน 5 นาที และการรู้จักรอคอยเวลาเล่นกับเพื่อน				

อายุ 42 เดือน (หมายถึง 3 ปี 6 เดือน 29 วัน)

ด้านการเคลื่อนไหว	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา	ด้านการเข้าใจภาษา	ด้านการใช้ภาษา	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
1. ยืนขาเดียว 5 วินาที ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 2. ใช้แขนรับลูกบอลได้ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	3. แยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 4. ประชิ้นส่วนของรูปภาพที่ถูกต้องออกเป็น 3 ชิ้นได้ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 5. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	6. วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลังได้ตามคำสั่ง ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 7. เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภทเสื้อผ้าได้ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน	8. พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปใหม่ ๆ ได้ ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 9. พูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้ได้เอง”	10. บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน 11. ใส่เสื้อผ่าหน้าได้เองโดยไม่ต้องติดกระดุม ☐ ผ่าน ☐ไม่ผ่าน
วิธีฝึกทักษะ **ตัวอย่างการฝึกยืนขาเดียว** 1. ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู 2. ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง 3. ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้ว บอกให้เด็กทำตาม เมื่อเด็กยื่นได้ให้เปลี่ยนเป็นเด็กข้างเดียว 4. เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ค่อย ๆ ปล่อยมือให้เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยทำซ้ำเช่นเดียวกัน **ผ่าน:** เด็กยืนขาเดียวได้นาน 5 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง	**ตัวอย่างการฝึกต่อก้อนไม้** 1. สอนให้เด็กรู้จัก รูปทรงวงกลม รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยม 2. วางจาน 3 ใบไว้ข้างหน้าเด็ก แยกรูปทรงทังสามรูปทรงไว้ในจานอย่างละ 1 ชิ้น 3. บอกให้เด็กหยิบรูปทรงกรมใส่ในจานวงกลม ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้ชี้ไปที่จานที่มีรูปทรงวงกลม แล้วให้เด็กหยิบวงกลมใส่จาน 4. บอกเด็กให้หยิบรูปทรงที่เหลือใส่ในจานที่มีรูปทรงเหมือนกัน หากเด็กทำไม่ได้ ให้ชี้ไปที่จานที่มีรูปทรงนั้น ๆ ให้เด็กหยิบรูปทรงใส่จาน จนครบทั้งหมด 5. ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถทำได้เอง **วัสดุที่ใช้แทนได้ :**สิ่งของในบ้านชนิดอื่นๆที่ไม่เป็นอันตราย - รูปทรงวงกลม เช่น ส้ม ◯ - รูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น กล่อง □ - รูปทรงสามเหลี่ยม เช่น ขนมเทียนพับใบตองเป็นสามเหลี่ยม △ ควรฝึกเด็กวาด ◯ ถ้าเด็กวาดไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กวาดจนได้	**ตัวอย่างการฝึกวางของหน้า-หลัง** 1.ของเล่นหลาย ๆ ชนิดที่สามารถวางของข้างหน้าและข้างหลังได้ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ถ้วย ก้อนไม้ แสดงวิธีให้เด็กดูพร้อมอธิบาย และชวนให้ทำตาม เช่น “ดูซิก้อนไม้อยู่หน้าโต๊ะ ก้อนไม้อยู่ข้างหลังโต๊ะ” สั่งเด็ก “วางก้อนไม้ ไว้ข้างหน้าโต๊ะ” 2. ถ้าเด็กไม่ทำตามหรือทำตามไม่ถูกให้แสดงให้ดูซ้ำ พร้อมทั้งช่วยจับมือเด็กทำหรือชี้พร้อมกับพูดเน้น “ข้างหน้า” และ “ข้างหลัง” 3. ขณะเล่นกับเด็กให้วางของเล่นที่คล้ายๆกันไว้ข้างหน้า 1ชิ้น และข้างหลัง 1 ชิ้น พูดบอกให้เด็กหยิบ เช่น “หยิบรถที่อยู่ข้างหลังเก้าอี้ซิ”	**ตัวอย่างการฝึก “ขอ” “ขอบคุณ”** 1. พ่อแม่ ผู้ปกครองทำตัวอย่างการพูด “ขอ” “ขอบคุณ” “ให้” ให้เด็กได้ยินบ่อยๆ เช่น 1.1 แม่พูดคำว่า “ขอ....ให้แม่นะจ๊ะ” กับลูกก่อนเวลาที่จะเอาของเล่นหรือขนมจากมือลูก โดยที่ไม่แย่งของจากเด็กก่อน 1.2 เมื่อเด็กยื่นของที่อยู่ในมือให้แล้วแม่พูดคำว่า “ขอบใจจ๊ะ เป็นเด็กดีมากที่รู้จักแบ่งของให้คนอื่น” 1.3 เวลาแม่มีขนมต้องการแบ่งให้ลูกรับประทานให้พูดกับเด็กว่า “วันนี้แม่ซื้อขนมมาด้วย จะแบ่งให้หนูและพี่ ๆ กินด้วยกันนะจ๊ะ กินด้วยกันหลายคนสนุกดี” 2. สอนและกระตุ้นให้เด็กพูด “ขอ” “ขอบคุณ” “ให้” เช่น ฝึกเด็กให้รู้จักขอ, การแบ่งปันและการให้ เช่น แบ่งขนม ของเล่น ให้เพื่อน ๆ หรือคนรอบข้าง แล้วบอกให้เด็กพูดว่า “ให้”	**ตัวอย่างการฝึกลบอกเพศ** 1. สอนให้เด็กรู้ความแตกต่างของเพศชายและหญิง จากการแต่งตัว ทรงผม 2. บอกให้เด็กรู้ถึงเพศของสมาชิกในครอบครัว เช่น แม่เป็นผู้หญิง พ่อเป็นผู้ชาย หนูเป็นผู้หญิง **ควรฝึกให้เด็กบอก** ชื่อจริงและนามสกุลเต็มได้
เด็กอายุ 3 ปีครึ่ง พบว่าพัฒนาการที่ล่าช้ามักมี 3 เรื่อง คือ การวาดรูปวงกลมตามแบบได้ การรู้จักขอบคุณ และการใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง				

สรุปพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน

ด้านการเคลื่อนไหว

9 เดือน	18 เดือน	30 เดือน	42 เดือน
27 ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน 28 ที่นคลู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่องเรือนสูงระดับอก	50 วิ่งได้ 51 เดินถีบลูกบอลไปได้ไกล 3 เมตร	70 กระโดดข้ามเชือกบนพื้นไปข้างหน้าได้ 71 ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ	90 ยืนขาเดียว 5 วินาที 91 ใช้แขนรับลูกบอลได้

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก

29 หยิบก้อนไม้จากพื้น และถือไว้มือละชิ้น 30 ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆ หยิบของขึ้นจากพื้น	52 เปิดหน้าหนังสือที่ทำด้วยกระดาษแข็งทีละแผ่นได้เอง 53 ต่อก้อนไม้ 2 ชิ้น	72 ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน 73 ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น ตามคำสั่ง (รู้จำนวน1เท่ากับ 1)	92 แยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ 93 ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้ 94 เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

ด้านการเข้าใจภาษา

31 ทำตามคำสั่งง่ายๆ เมื่อใช้ท่าทางประกอบ	54 เลือกวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง 3 ชนิด 55 ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน	74 สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที 75 วางวัตถุไว้ "ข้างบน" และ "ข้างใต้" ตามคำสั่งได้	95 วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลังได้ตามคำสั่ง 96 เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภทเสื้อผ้าได้

ด้านการใช้ภาษา

9 เดือน	18 เดือน	30 เดือน	42 เดือน
32 เด็กรู้จักการปฏิเสธด้วยการแสดงท่าทาง 33 เลียนเสียงคำพูดที่คุ้นเคยได้อย่างน้อย 1 เสียง	56 พูดเลียนคำที่เด่นหรือคำสุดท้ายของคำพูด 57 พูดเป็นคำๆ ได้ 4 คำ เรียกชื่อสิ่งของหรือทักทาย (ต้องเป็นคำที่นที่ไม่ใช่ พ่อแม่ ชื่อของคนคุ้นเคย หรือชื่อของสัตว์เลี้ยงในบ้าน)	76 พูดติดต่อกัน 2 คำขึ้นไปอย่างมีความหมายโดยใช้คำกริยาได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา	97 พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปใหม่ๆได้ 98 พูด "ขอ" หรือ "ขอบคุณ" หรือ "ให้" ได้เอง

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

34 ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้	58 สนใจ/มองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้ที่คลู่ไกลตกไปไกลห่างนัยตา 3 เมตร 59 ดื่มน้ำจากแก้วโดยไม่หก	77 ร้องเพลงได้บางคำหรือร้องเพลงคลอตามทำนอง 78 เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเองในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก	99 บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง 100 ใส่เสื้อผ้าหน้าได้เองโดยไม่ต้องติดกระดุม

การดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน

ปัญหา	อาการแสดงสำคัญ	วิธีกระตุ้นและดูแล

1. สมาธิสั้น



ซนเกินไป
ใจลอย
คอยไม่ได้

1. ดึงความสนใจ : ลดสิ่งเร้า สบตา สัมผัสตัว
2. บอกความต้องการ : สั้น ชัด หนักแน่น จำกัดเวลา สั่งทีละอย่าง
3. เช็คความถูกต้อง ให้พูดทวน

2. เรียนรู้บกพร่อง



อ่านเพี้ยน
เขียนผิด
คิดเลขพลาด

1. เลี้ยงดูตามปกติไม่ให้สิทธิพิเศษ หาจุดเด่น ของเด็กมาสร้างความภูมิใจ
2. ช่วยการฝึกอ่านเขียนคำนวณให้ถูกต้อง

3. สติปัญญาบกพร่อง



เชื่อคนง่าย
ไร้ไหวพริบ
คิดอ่านช้า

1. ฝึกสอนตามระดับความสามารถจริง : การช่วยเหลือตนเอง ทักษะสังคม ฝึกอาชีพ
2. ส่งเสริมความสามารถด้านอื่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ เช่น ดนตรี กีฬา งานช่างงานฝีมือ

4. ออทิสติก



ไม่สบตา
ไม่พาที
ไม่ชี้นิ้ว

1. กระตุ้นให้เด็กสื่อสาร
2. ให้ความสนใจเด็ก เช่น สบตา พูดช้าๆ ชัดๆ ทำเสียงให้น่าสนใจ
3. ให้รางวัล ชมเชย เมื่อมีพฤติกรรมเหมาะสม เพิกเฉยเมื่องอแง

การดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ที่จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งทักษะและความรู้ในการเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ช่วงวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางร่างกายและจิตใจ ร่างกายจะเจริญเติบโตเต็มที่ ฮอร์โมนเพศทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นหนุ่มเป็นสาว วัยรุ่นจึงทำให้คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นวัยเสี่ยง เพราะมักจะมีปัญหาหลายรูปแบบ เช่น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ท้องไม่พร้อม ดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด ทะเลาะตบตี ใช้ความรุนแรง หนีออกจากบ้าน ฆ่าตัวตาย อสม.ควรส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น ดังนี้

สอดส่องมองหาและคัดแยกกลุ่มวัยรุ่น

กลุ่มวัยรุ่น	ความหมาย	คำแนะนำ
เด็กขาว	คือวัยรุ่นที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้ถูกต้อง	หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบสังคม
เด็กเทา	คือวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม	หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่นำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดี แนะนำให้ทราบในสิ่งที่ถูกต้อง
เด็กดำ	คือวัยรุ่นที่เคยปฏิบัติตัวในทางที่ผิด	ให้กำลังใจ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่ทำ ผิดซ้ำ

ทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่น

เทคนิคการสื่อสารกับลูกวัยรุ่น โดยใช้บันได 9 ขั้นสู่การเปิดใจคุยกับลูกวัยรุ่น

ขั้นที่ 9 พูดคุย : พูดคุยกันสม่ำเสมอ

ขั้นที่ 8 มั่นใจ:มั่นใจที่จะคุยทุกเรื่องกับลูก

ขั้นที่ 7 มีความรู้ : ให้ความรู้กับลูกได้

ขั้นที่ 6 เป็นเพื่อน : ให้ความรักและสัมพันธภาพที่ดี

ขั้นที่ 5 ให้เวลา : ให้ความสำคัญกับลูกเสมอ

ขั้นที่ 4 ยอมรับ: ยอมรับในตัวตนของลูก

ขั้นที่ 3 รับฟัง : รับฟังอย่างตั้งใจ ไม่มีอคติ

ขั้นที่ 2 เปิดใจ : เปิดโอกาสเรียนรู้เรื่องลูก

ขั้นที่ 1 เข้าใจ : เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น



สื่อสารเชิงบวก สื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว

วิธีการการสื่อสารกับลูกวัยรุ่น

1.การสื่อความประทับใจ: แสดงความชื่นชมกันในครอบครัว



ลูกแม่เก่งจังเลยหรือแม่ทำอาหารอร่อยมากค่ะ

2. สื่อความกังวล: เป็นการบอกถึงความห่วงใย



วันนี้เป็นอะไรไปลูก ไม่สบายหรือเปล่า มีปัญหาอะไรจะเล่าให้แม่ฟังไหม

3. การให้ข้อมูลใหม่: เล่าเหตุการณ์กิจกรรม กับครอบครัว



วันนี้มีข่าวคนเมายาบ้าจับเด็กเป็นตัวประกัน ลูกต้องระวังตัวนะ ยาบ้าเป็นสิ่งไม่ดี อย่าไปยุ่งเกี่ยว

4. ปรับความเข้าใจกัน: พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกัน



สองวันมานี้ลูกกลับบ้านค่ำ มีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนไหม

5. คอยตักเตือน: ให้คำแนะนำดีๆต่อกัน



ให้คำแนะนำดีๆต่อกัน

6. ปลุกปลอบใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน



วันนี้คะแนนสอบไม่ดี ไม่เป็นไรนะลูก ตั้งใจอ่านหนังสือครั้งหน้าหนูทำได้ดีแน่นอนจ๊ะ

การดูแลสุขภาพจิตวัยทำงานทำงาน

วัยทำงานเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญมากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตคือช่วงวัยของการทำงาน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องอาศัยแรงกายแรงใจในการหาเลี้ยงชีพและครอบครัว เป็นช่วงวัยที่มีบทบาทสำคัญ ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ในการทำงานนั้นก็มักจะพบกับสิ่งคุกคามสุขภาพหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละอาชีพ ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว วัยนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพทางจิตใจได้มาก เช่น ภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า ปัญหาครอบครัว หนี้สิน หรือปัญหาส่วนตัวอื่นๆ อีกทั้งประชากรวัยทำงานยังเป็นกลุ่มคนที่มีการฆ่าตัวตายสูงที่สุดอีกด้วย ดังนั้น อสม.ผู้อยู่ใกล้ชิดในชุมชน จึงควรมีบทบาทในการดูแลและป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในวัยนี้เช่นกัน

อสม.ควรสอดส่องมองหา

กลุ่มเสี่ยงต่อความเครียดและภาวะซึมเศร้า

“ภาระหนัก รายได้น้อย ใช้สอยมาก ปราศจากมิตร คิดไม่ตก หมกมุ่นกับตนเอง”

กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

“ซึมเศร้า ป่วยเรื้อรัง เป็นโรคจิต ติดสุรายาเสพติด คิดหรือเคยฆ่าตัวตาย มีปัญหาครอบครัว ปรับตัวไม่ได้”

1. ความเครียด

1) ประเมินความเครียดด้วยแบบประเมิน ST5

ประเมินโดยให้คะแนน 0 - 3 ที่ตรงกับความรู้สึก

คะแนน 0 หมายถึง แทบไม่มี คะแนน 2 หมายถึง บ่อยครั้ง

คะแนน 1 หมายถึง บางครั้งครั้ง คะแนน 3 หมายถึง เป็นประจำ

ข้อที่	อาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 2 - 4 สัปดาห์	คะแนน			
		0	1	2	3
1.	มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก				
2.	มีสมาธิน้อยลง				
3.	หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ				
4.	รู้สึกเบื่อ เซ็ง				
5.	ไม่อยากพบปะผู้คน				

การแปลผล

คะแนน 0 - 4 เครียดน้อย คะแนน 5 - 7 เครียดปานกลาง

คะแนน 8 - 9 เครียดมาก คะแนน 10 - 15 เครียดมากที่สุด

เมื่อประเมินแล้วพบว่ามีความเครียดในระดับมากถึงมากที่สุด **(คะแนนตั้งแต่ 8 ขึ้นไป)** อสม.ควรให้คำแนะนำการจัดการความเครียด และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2) ให้คำแนะนำในการจัดการกับความเครียด

- ผ่อนคลายตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น ออกกำลังกาย นอนพักผ่อน กินอาหารอร่อย ดูหนังฟังเพลง หรือหาคนพูดคุย เป็นต้น
- การฝึกคลายความเครียดด้วยการฝึกหายใจ โดยหายใจเข้าช้า ๆ นับ 1 - 4 ในใจ กลั้นหายใจ นับ 1 - 4 และหายใจออกช้า ๆ นับ 1 - 4
- การผ่อนคลายความเครียดที่ไม่เหมาะสม คือ “กินเหล้า เคล้านารี ผีพนัน เที่ยวมันกลางคืน”

2. ภาวะซึมเศร้า

1) ประเมินภาวะซึมเศร้าด้วย 2Q (สองคำถาม)

คำถาม	ไม่ใช่	ใช่
1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่	0	1
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่	0	1

การแปลผล ถ้ามี 1 คะแนนขึ้นไปถือว่ามีแนวโน้มภาวะซึมเศร้า อสม.ควรให้คำปรึกษาเบื้องต้น แนะนำการจัดการกับอารมณ์เศร้า และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป

2) การดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า สำหรับ อสม.

- พูดคุย ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ
- แนะนำออกกำลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 30 นาที เช่น เดินเร็ว วิ่ง
- ให้สร้างเสียงหัวเราะแก่ตัวเอง เช่น ดูภาพยนตร์ตลกหรืออ่านหนังสือการ์ตูน ขบขัน
- ให้ระบายอารมณ์ออกมา เช่น ตะโกน ร้องไห้ หรือเขียนความรู้สึกลงในสมุดบันทึก
- ให้มองโลกในแง่ดี ทุกปัญหาย่อมมีทางออก ทุกอุปสรรคย่อมมีโอกาส

3. สุรา/สารเสพติด

การดื่มสุราในวัยทำงาน สังคมไทยอาจมองเป็นเรื่องปกติและสามารถทำได้ง่าย ๆ เนื่องจากเป็นสารเสพติดที่ถูกกฎหมาย ในงานรื่นเริงต่าง ๆ นิยมใช้สุราเป็นเครื่องดื่ม รวมถึงวัฒนธรรมของบางพื้นที่ที่ร่วมวงดื่มสุราเป็นการให้เกียรติเจ้าบ้าน ดังนั้นสิ่งที่ อสม.ควรปฏิบัติคือ เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการลด ละ เลิก สุรา/สารเสพติด สอดส่องมองหาผู้ที่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดแล้วมีความเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือ

ผู้ที่เจ็บป่วยทางร่างกายแล้วเริ่มดื่มสุรา และผู้ที่ไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนปกติทั่วไป ไต่ถามทุกข์สุขเพื่อทราบเรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิต หรือสาเหตุของการดื่มสุรา/สารเสพติด อสม.สามารถสังเกตได้จากความถี่ของการดื่ม ทั้งนี้การดื่มสุราเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดและส่งผลให้มีความเกี่ยวโยงกับสารเสพติดประเภทอื่น ๆ ตามมาได้ กรณีที่ อสม.ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ควรส่งต่อ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อประเมินอาการและให้ความช่วยเหลือต่อไป

4. **การฆ่าตัวตาย**

“สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย”

พูด	เขียน	แสดงออก
• พูดถึงการฆ่าตัวตายบ่อยๆ • พูดประชดประชันเน้นปมด้อยของตนเอง • บ่นเบื่อหน่ายสิ้นหวังกับชีวิตอยู่ไปก็ไม่มีความหมายกับใคร • พูดเพ้อไม่รู้เรื่องหรือพูดเรื่องบาปบุญเวรกรรมเกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้า	• เขียนจดหมายเพื่อระบายความรู้สึก (มีลักษณะเหมือนกับการพูด) • เขียนจดหมายลาตาย	• แสดงกิริยาหมดหวังท้อแท้ซึมเศร้า • แสดงออกเพื่อการประชดประชันหรือเพื่อต้องการการเอาใจใส่ดูแล • บุคลิกภาพ แปลกหรือเปลี่ยนไปมาก • คล้ายคนเมาสุราหรือใช้สารเสพติด • วางแผนเตรียมอุปกรณ์กำหนดวันเพื่อฆ่าตัวตาย

3ส. วัคซีนป้องกันการฆ่าตัวตาย

เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว



การดูแลสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

การดูแลสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยที่มีลักษณะพิเศษคือ เป็นแหล่งขุมทรัพย์ความรู้ ความชำนาญที่มีคุณค่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และเป็นสายใยแห่งครอบครัว ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างบุคคลในช่วงวัยต่าง ๆ ได้ดี แต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาในด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ มากกว่าวัยอื่นๆ เพราะเป็นวัยที่การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายเสื่อมลง อีกทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุบางรายอาจพบโรคเรื้อรังที่เป็นมาตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงวัยทำงานอีกด้วย นอกจากการเสื่อมของสภาพร่างกายแล้ว การสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคม ยังส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ จากการสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุขพบว่า**ปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ วิตกกังวล และซึมเศร้า**

ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต

“ป่วยเรื้อรัง อยู่ลำพังไร้คู่ ไม่มีผู้ดูแล คนแก่ติดเตียง”

ป่วยเรื้อรัง	**คือ** ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังทางกาย เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ไตวาย อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเสื่อม
อยู่ลำพังไร้คู่	**คือ** ผู้สูงอายุที่เป็นโสด หรือคู่สมรสตายจาก
ไม่มีผู้ดูแล	**คือ** ผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลาน หรือผู้ดูแลใกล้ชิด อยู่บ้านเพียงลำพัง หรือเป็นผู้สูงอายุคู่สามีภรรยาที่ดูแลกันเองตามลำพัง เป็นต้น
คนแก่ติดเตียง	**คือ** ผู้ป่วยนอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุกลุ่มปกติ (ติดสังคม)	ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง (ติดบ้าน/ติดเตียง)
1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสุข ลดความเศร้า เหงา ว้าเหว่ในชุมชน 2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกาย **เน้น** การออกกำลังกายและอาหารที่มีประโยชน์	1. ประเมินความเครียดด้วย แบบประเมิน ST5 2. ประเมินภาวะซึมเศร้าด้วย แบบประเมิน 2Q (สองคำถาม) 3. ติดตาม เยี่ยมเยียน ถามไถ่ สร้างกำลังใจ ให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
และป้องกันภาวะสมองเสื่อมด้วยกิจกรรม “ความสุข 5 มิติ”



ความสุข 5 มิติ	กิจกรรม
1. สุขสบาย ร่างกาย แข็งแรงอาหาร เหมาะสม	ออกกำลังในชุมชน และกินอาหารรสจืด **ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม**
2. สุขสนุก บันเทิง รื่นเริงใจ ร้องรำ ทำเพลง	กิจกรรมดนตรีในชุมชน การร้องรำทำเพลง
3. สุขสง่า ภูมิใจตนเอง แบ่งปัน สังคม	กิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น เช่น จิตอาสา การช่วยงานบุญ งานศพ
4. สุขสว่าง ความจำดี มีเหตุผล	กิจกรรมบริหารสมอง เช่น ชวนคิดเลขง่าย ๆ ในใจ
5. สุขสงบ สงบข้างในใจต้องนิ่ง	กิจกรรมเสริมการรับรู้และจัดการของอารมณ์ เช่น นั่งสมาธิ ฟังธรรม ฝึกควบคุมอารมณ์

การดูแลจิตใจเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติ

เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น สึนามิ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ดินถล่ม พายุ ภัยแล้ง ภัยพิบัติจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย ตึกถล่ม เพลิงไหม้ เครื่องบินตก อุบัติเหตุหมู่ รวมถึงภาวะวิกฤต เช่น ฆ่าตัวตาย อุปทานหมู่ ความขัดแย้งทางการเมือง เป็นต้น

เหตุการณ์วิกฤตเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบอย่างมากทั้งทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ไม่เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านั้น แต่รวมถึงญาติ ผู้ใกล้ชิด และผู้เห็นเหตุการณ์ ดังนั้น อสม.ผู้อยู่ใกล้ชิดกับคนในชุมชน ควรใช้หลักการปฐมพยาบาลทางใจ (3ส) ในการดูแลช่วยเหลือ









สอดส่อง มองหา

LOOK

รายงานสถานการณ์ วิกฤตในพื้นที่
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง

ข้อมูลสำคัญที่ต้องรายงาน ได้แก่
1. เกิดเหตุอะไรขึ้น
2. สถานที่เกิดเหตุ
3. ระยะเวลาที่เกิดนานแค่ไหน
4. จำนวนคนที่ได้รับผลกระทบมีเท่าไร
5. เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง

สำรวจกลุ่มเสี่ยง


โศกเศร้าเสียใจรุนแรง


กินไม่ได้


นอนไม่หลับ


เด็ก


คนชรา


ผู้พิการ

อาจจะใช้แบบประเมิน BS4 (ข้อมูลค้นหากลุ่มเสี่ยง 4 ข้อ)

ข้อมูลค้นหากลุ่มเสี่ยง 4 ข้อ (BS 4)
(สำหรับเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัคร)

ชื่อ-นามสกุล.....อายุ .....ปี วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน ...../...../..... ที่พัก.....
เบอร์โทร / บุคคลที่ติดต่อได้.....

แบบประเมินกลุ่มเสี่ยงวิกฤตสุขภาพจิต (BS4) ช่วงเวลา 2 – 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา	มี	ไม่มี
1.1มีประวัติการรักษาทางจิตเวชมาก่อน หรือใช้ยาทางจิตเวช เช่น ยาคลายเครียด ยานอนหลับ		
1.2 เคยใช้สารเสพติด เช่น สุรา, กัญชา, ยาบ้า ฯลฯ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา		
1.3มีโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาทุกวัน หรือความพิการที่ต้องการดูแลพิเศษหรือไม่		
1.4 ท่านรู้สึกเครียด กังวล ท้อแท้ สิ้นหวัง จนรบกวนการดำเนินชีวิต ในช่วง 2 สัปดาห์นี้		

***เมื่อพบข้อใดข้อหนึ่งให้ส่ง ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) /พยาบาล/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิต ด้วยแบบประเมินความเครียด (ST5) และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (DS8)

ใส่ใจ รับฟัง
LISTEN

01



ใช้น้ำเสียง

ท่าทางแสดงความเป็นมิตร
แสดงถึงความอบอุ่น เข้าใจ

02



ใช้การฟังอย่างตั้งใจ

แสดงความเข้าอกเข้าใจ อดทนรับฟัง
หากเขายังเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆ

03



ยอมรับปฏิกิริยา

ทางอารมณ์ที่รุนแรง
ของผู้ประสบภาวะวิกฤต

04



เป็นตัวแทน

ในการติดต่อ

05



ให้ความช่วยเหลือ

ตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม
หรือตามความต้องการ

06



ทำความเข้าใจ

และยอมรับวัฒนธรรม
ความเชื่อ ภาษา ที่แตกต่าง

07



ปฏิบัติกับเด็ก

ด้วยความจริงใจเท่าเทียม

มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับผู้ใหญ่

08



ให้ข้อมูล

(ว่าอารมณ์ต่างๆ)
ที่เอ่อท่วมท้น อาจคงอยู่ไประยะหนึ่ง

ส่งต่อ เชื่อมโยง
LINK

การติดตามเยี่ยมบ้าน

เมื่อทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมแล้ว อสม. ควรติดตามเยี่ยมเยียนผู้ประสบภาวะวิกฤต และประเมินว่า เขาดีขึ้นหรือไม่ ยังมีความต้องการด้านไหนอีกไหม เพื่อรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบต่อไป



ช่วยเหลือ
ตามความจำเป็นพื้นฐาน

เช่น น้ำ อาหาร ยา



หากควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
โศกเศร้ารุนแรง มีความคิด
อยากฆ่าตัวตาย ให้ส่งต่อ



ติดต่อครอบครัว
หรือชุมชนของคนนั้น

หากมีปัญหาสุขภาพจิต
เช่น เครียด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ควรรับบริการจากสถานบริการใกล้บ้าน
หรือ โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323

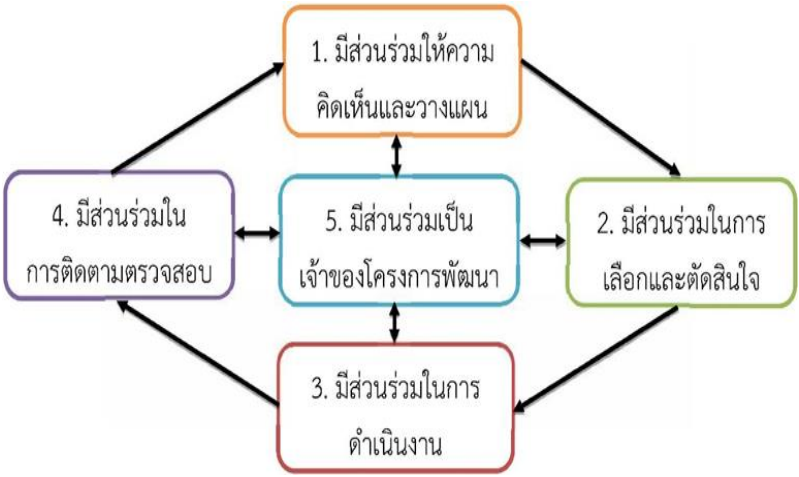
การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อชุมชนสุขภาพจิตดี

ทำไมต้องสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ถ้าชุมชนใดมีคนที่สุขภาพจิตไม่ดีเป็นจำนวนมาก ชุมชนนั้นจะไม่น่าอยู่ ทุกคนอยู่อย่างไม่มีความสุข เป็นชุมชนที่ยากต่อการพัฒนาให้ก้าวหน้า อสม.เป็นแกนนำที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน รับรู้ปัญหา และได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากคนในชุมชน ดังนั้น อสม.จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนของตนมีสุขภาพจิตดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับฟัง เรียนรู้และทำความเข้าใจ ร่วมเสนอปัญหา นำไปสู่การพัฒนาชุมชน

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน



บทบาทของ อสม. ในการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

1. พบปะพูดคุยปรึกษาหารือกับเพื่อน อสม.ด้วยกันบ่อย ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายให้กระชับแน่น

2. ชักชวนเพื่อน อสม.ให้ร่วมวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้แบบประเมินที่มีอยู่ เช่น แบบประเมินความเครียด แบบประเมินภาวะซึมเศร้าเป็นต้น จะทำให้พอรู้ว่าคนในชุมชนของเรามีใครบ้างที่ต้องให้ความใส่ใจช่วยเหลือใกล้ชิด

3. ให้ อสม. 1 คน ดูแล 10 หลังคาเรือน ให้แต่ละคนนัดสมาชิกในครอบครัวที่สมัครใจร่วมประชุมเพื่อร่วมระดมความคิด ร่วมวางแผนและร่วมทำงาน

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิด อาจใช้วิธีพูดคุยถกปัญหาเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ปัญหาปากท้อง ปัญหาความเจ็บป่วย ปัญหายาเสพติด ปัญหาความเครียด (อาจใช้ข้อมูลจากแบบประเมินที่ได้มาพูดคุยกับชาวบ้าน) แล้วนำมาสู่การวางแผนปฏิบัติ

5. เมื่อทำงานมาระยะหนึ่ง ควรรวมกลุ่ม อสม.ไปเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามประเมินผล การเยี่ยมบ้านควรให้ความเป็นกันเอง พูดคุยสอบถามว่าทำอะไรไปบ้าง ผลเป็นอย่างไร มีอะไรให้ช่วยบ้าง ที่สำคัญ ไม่ควรคาดหวังผลหรือมุ่งผลักดันชาวบ้านว่าต้องทำงานสำเร็จ

วิธีการประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยใช้เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี (Top model) สำหรับ อสม.

ขั้นตอนที่ 1 กล่าวนำให้เห็นเป้าหมายร่วมกัน

- กล่าวนำเริ่มการประชุมพร้อมกับอธิบายและเน้นให้เห็นความสำคัญของการมาพูดคุย แสดงความคิดเห็น
- บอกขั้นตอนการพูดคุยและระยะเวลา
- กำหนดกติกาการพูดคุยร่วมกันเช่น หนึ่งคนต่อหนึ่งความคิดเห็น เมื่อคนอื่นพูดต้องฟังให้จบ

ขั้นตอนที่ 2 สำรวจปัญหาในชุมชนร่วมกัน

พาสำรวจปัญหาในชุมชนโดยการตั้งคำถามง่ายๆให้ที่ประชุมระดมความคิดด้วย 4 คำถาม



1. เราเห็นปัญหาอะไรในชุมชน
2. เรารู้สึกอย่างไรกับปัญหานั้น
3. เรียนรู้อะไรกับปัญหาที่เกิดขึ้น
4. เราจะป้องกันแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 3 ระดมความคิดทั้งจากรายบุคคลและรายกลุ่ม

- ขอให้สมาชิกทุกคนเขียนความคิดของแต่ละคนลงบนแผ่นกระดาษ
- ให้สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดของทุกคน
- นำบัตรความคิดไปติดไว้บนกระดาน

ขั้นตอนที่ 4 จัดหมวดหมู่ความคิดที่คล้ายกันให้อยู่ในหมวดเดียวกัน

- ขอให้กลุ่มจัดความคิดที่เกี่ยวข้อง/ คล้ายคลึงกันจำนวน 4 - 8 คู่ตามความรู้สึก
- ติดป้ายหรือหางบัตรที่แต่ละหมวดหมู่อย่างเร็ว ใช้คำ 1 – 2 คำ
- จัดหมวดหมู่ต่าง ๆ เหล่านี้ให้ชัดเจนดูดีขึ้น โดยจัดเรียงบัตรความคิดทุกใบที่ติดบนกระดานให้ถูกต้องเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 5 นำความคิดเห็นที่ได้มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

กิจกรรม	ระยะเวลา				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการรวบรวม	ผู้รับผิดชอบ
	1	2	3	4			

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ปี 2551 หมวด 3 มาตรา 22 กล่าวว่า บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา

1. มีภาวะอันตราย เช่น คลุ้มคลั่ง อาละวาด ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น ทำลายข้าวของ เป็นต้น

2. มีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา เช่น พูดคนเดียว หูแว่ว การดูแลตนเองเสียไป

หรือมีพฤติกรรมแปลกอื่นๆ

มาตรา 23 ผู้ใดพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา 22 ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจโดยไม่ชักช้า

ดังนั้น อสม. ผู้อยู่ใกล้ชิดคนในชุมชนควรให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโดยการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้นำชุมชน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ อสม. ยังสามารถนำพาชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนทั้งรายเก่าและรายใหม่ดังนี้

1) ช่วยกันดูแล ติดตาม ให้ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่อง
2) ร่วมพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจากการถูกเอาเปรียบจากสังคม
3) เฝ้าระวังสังเกตอาการ หากผิดปกติหรือมีอาการกำเริบ ให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
4) ส่งเสริมอาชีพ หางานอดิเรกให้ทำ เพื่อฝึกสมาธิ และให้ผู้ป่วยมีรายได้
5) ให้กำลังใจผู้ป่วย และสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนได้

ที่มา:

☐ มีผู้ป่วยปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวนมาก ถูกละเลยทอดทิ้ง

☐ ถูกกีดกันจากสังคม

☐ อาการกำเริบจากการไม่ได้รับการดูแลต่อเนื่อง

สาเหตุ:

☐ ครอบครัวและชุมชนไม่ยอมรับ

☐ ผู้ป่วยขาดผู้ดูแลในชุมชน

☐ ขาดระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในชุมชน

ผล:

☐ ผู้ป่วยขาดยาอาการกำเริบต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานหรือเกือบตลอดชีวิต

☐ ผู้ป่วยเกิดความเสื่อมทางบุคลิกภาพจนไม่สามารถคืนสู่สังคมได้

☐ ผู้ป่วยทำร้ายตนเอง

องค์ประกอบของชุมชนในการดูผู้ป่วยจิตเวช

- ครอบครัว
- ชุมชน
- ทีมบุคลากรสาธารณสุข

เป้าหมาย

- มุ่งเน้นการดูแลโดยครอบครัวและชุมชนเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุข
- รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเฉพาะรายที่มีอาการรุนแรงซับซ้อน
- รับไว้รักษาในโรงพยาบาลในระยะสั้นๆ และกลับสู่ชุมชนเร็วขึ้น
- มีระบบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน

ก่อนการมีโรคกำเริบ (Prodromal phase)

- ☐ ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องโรคจิตแก่ชุมชน
- ☐ บุคลากรทางการแพทย์ในชุมชนมีระบบคัดกรองติดตามกลุ่มเสี่ยง
- ☐ มีการคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยแบบคัดกรองโรคจิต
- ☐ ให้การรักษาโดย
  - เน้นการให้คำปรึกษาแกกลุ่มเสี่ยงและครอบครัว
  - ส่งต่อจิตแพทย์กรณีผู้ป่วยมีอาการโรคจิตชัดเจนเพื่อใช้ยาต้านโรคจิตหรือการรักษาตามสภาพ

ระยะเฉียบพลัน (Acute phase)

เป้าหมายคือ ป้องกันอันตรายลดอาการโรคจิตควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าว หรือเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สร้างสัมพันธภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ส่วนใหญ่จะรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล

การรักษาในระยะเฉียบพลัน (Acute phase) จะต้องใช้หลายวิธี ได้แก่

- ☐ การรักษาด้วยยาต้านโรคจิต (Anti psychotic drugs)
- ☐ การทำให้ชักด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive therapy)
- ☐ การทำจิตสังคมบำบัด (Psychosocial intervention)
  - Psycho education การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
  - Social skill training การฝึกทักษะทางด้านสังคม
  - Problem solving skill training การฝึกทักษะการเผชิญและแก้ไขปัญหา
  - Occupational training การฟื้นฟูทางด้านอาชีพ
- ☐ การติดตามผลการรักษาในชุมชนเพื่อป้องกันการกำเริบซ้ำและพัฒนาศักยภาพหรือเพิ่มคุณภาพชีวิต

<u>ระยะทำให้คงสภาพ (Stabilization phase)</u> เป็นการดูแลผู้ป่วยในครอบครัวและชุมชนโดย

☐ เสริมสร้างการปรับตัวในชุมชน/ เตรียมความพร้อมครอบครัวชุมชนในการดูแลผู้ป่วย

☐ ป้องกันไม่ให้ป่วยซ้ำอีกโดยดูแลให้ยาต่อเนื่องลดปัจจัยกระตุ้นเช่นความเครียด สารเสพติดสิ่งแวดล้อม

☐ ใช้ยาในขนาดเดิมที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและนานถึง6เดือน เพื่อป้องกันอาการกำเริบซ้ำ

☐ ให้คำปรึกษาครอบครัวลดการแสดงอารมณ์เสียต่อกันลดความคาดหวังการควบคุมผู้ป่วยมากเกินไป มีกลุ่มช่วยเหลือกันสำหรับครอบครัว (Self–help group) จัดระเบียบการดำรงชีวิต

☐ ประสานกับหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อจดทะเบียนผู้พิการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ

<u>การใช้ยาในระยะคงสภาพ (Stabilization phase)</u>

ใช้ยาขนาดและระยะเวลาที่นานเพียงพออาจปรับเพิ่ม/ลดขนาดยาตามความเหมาะสม

☐	Haloperidol	5-12 mg/d
☐	Chlorpromazine	300-600 mg/d
☐	Perphenazine	30-60 mg/d
☐	Risperidone	2-8 mg/d
☐	Fluphenazinedecanoate	สูงสุด 75 mg ทุก 2 wks.
☐	loperidoldecanoate	สูงสุด 300 mg ทุก 1 เดือน

การติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน

- ทำทะเบียนผู้ป่วย (Case registration) เพื่อทำตารางการนัดหมายและติดตามการรักษา

- ประเมินอาการโดยใช้แบบประเมินต่างๆ ความร่วมมือในการรับประทานยา/ฉีดยาและติดตามผลการรักษาทุกเดือน

- ประเมินความสามารถในการทำหน้าที่ทางสังคมการงานการดูแลตัวเองทุก 6 เดือน

- ประเมินคุณภาพชีวิตทุกปี

- เยี่ยมบ้านเพื่อดูสัมพันธภาพของคนในครอบครัวภาระที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยความเครียดภายในบ้าน

- เฝ้าระวังอาการกำเริบซ้ำพฤติกรรมรุนแรงในครอบครัวและชุมชน

- สร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดอคติต่อผู้ป่วยและช่วยเหลือดูแลฝึกอาชีพในกรณีที่ผู้ป่วยอาการทุเลาหายจากอาการทางบวกแพทย์อาจปรับลดขนาดการใช้ยาลงโดยมีเป้าหมายให้ ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงจากยาน้อยที่สุดโดยยังควบคุมอาการให้เป็นปกติ

- ถ้าผู้ป่วยมีอาการกำเริบมากกว่า 1 ครั้ง คงยาไว้อย่างน้อย 5 ปี หรือตลอดชีวิต

- Long– acting antipsychotic maintenance treatment ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติการกำเริบซ้ำบ่อยๆ หรือมีประวัติไม่ร่วมมือในการรับประทานยาหรือผู้ป่วยประสงค์ยาฉีดระยะยาว

ขนาดยาที่ใช้

- Fluphenazine decanoate 25 – 150 mg/2wks.
- Haloperidol decanoate 50 – 200 mg/4wks.

ปัญหาการดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่พบบ่อยและแนวทางการช่วยเหลือ

<u>อาการสำคัญที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคจิต</u>

- ☐ อาการประสาทหลอน
- ☐ อาการหลงผิด
- ☐ มีพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
- ☐ ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา
- ☐ ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาจิตเวช

อาการประสาทหลอน

วัตถุประสงค์ : ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถแยกแยะการรับรู้ของตนเองได้ตามความเป็นจริง

กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ

- ☐ สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
- ☐ ประเมินอาการประสาทหลอน
- ☐ รับฟังผู้ป่วยพูดไม่โต้แย้ง Present reality
- ☐ ไม่ส่งเสริมโอกาสในการเกิดประสาทหลอน
- ☐ ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา

อาการหลงผิด

วัตถุประสงค์ : ช่วยให้ผู้ป่วยมีความคิดอยู่ในความเป็นจริงให้มากที่สุด

กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ

- ☐ สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
- ☐ ประเมินความคิดหลงผิดให้ผู้ป่วยได้พูดถึงความคิดของตนเอง
- ☐ รับฟังความคิดเห็นไม่โต้แย้งหรือท้าทายไม่ล้อเล่น
- ☐ Present reality
- ☐ ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา

มีพฤติกรรมรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

วัตถุประสงค์ : ผู้ป่วยไม่เป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ

- ☐ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยประเมินความก้าวร้าว
- ☐ สังเกตพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการโต้แย้งพูดคุยกับผู้ป่วยด้วยท่าทีสงบมั่นคง
- ☐ จัดสิ่งแวดล้อมป้องกันอันตรายไม่อยู่กับผู้ป่วยลำพังหาบุคคลอื่นมาช่วย
- ☐ ควบคุมพฤติกรรมเมื่อก้าวร้าว
- ☐ ให้ยาตามแผนการรักษา
- ☐ ประสานผู้เกี่ยวข้องนำส่งโรงพยาบาลจิตเวช

ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา

วัตถุประสงค์ : ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรับประทานยาและได้รับยาครบถ้วน

กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ

- ☐ รับฟังผู้ป่วยพูดบ่นถึงอาการไม่สุขสบายที่เกิดจาก S/E ของยา
- ☐ ให้ข้อมูลถึงความจำเป็นในการรับประทานยาต่อเนื่องป้องกันการ Re-admitted แต่ไม่ข่มขู่
- ☐ ปรึกษาแพทย์ปรับจำนวนยาให้ยาน้อยมื้อเพื่อความสะดวก
- ☐ หากลืมบ่อยหาอุปกรณ์จัดเป็นUnitหรือญาติคอยเตือน
- ☐ ผู้ป่วยทิ้งยาบ่อยๆ ปรึกษาแพทย์ใช้ยาฉีด

ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาจิตเวช

อาการข้างเคียง	การดูแล/ ให้คำแนะนำ
- ง่วงนอน	- ปกติเกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อปรับตัวได้จะดีขึ้น - หลีกเลี่ยงการทำงานสูง/เครื่องจักร/การขับรถ - ถ้าง่วงมากรบกวนชีวิตประจำวันปรึกษาแพทย์
- ท้องผูก	- ดื่มน้ำเพียงพอ 6-8 แก้วต่อวัน - กินอาหารที่มีกากใยสูง - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- ปาก	- จิบน้ำบ่อยๆ/อมลูกอม
- วิงเวียน	- เปลี่ยนท่าช้าๆ
- น้ำหนักขึ้น	- ควบคุมอาหารและออกกำลังกาย

ญาติมีส่วนช่วยอย่างไร

- ☐ สังเกตอาการเตือน (Warning sign)
- ☐ หาสาเหตุกระตุ้นและหาทางแก้ไข
- ☐ ดูแลให้รับประทานยาตามแพทย์สั่ง
- ☐ เมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติให้พาผู้ป่วยมาพบแพทย์

ภาคผนวก

คณะทำงาน
พัฒนาคู่มือความรู้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน

ที่ปรึกษาคณะทำงาน

1. น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์	อธิบดีกรมสุขภาพจิต
2. นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
3. นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
4. นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
5. นางสุดา วงศ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
6. นายแพทย์มนตรี นามมงคล	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
7. ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
8. นางสิริพร พุทธิพรโอภาส	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
9. นางธิดา จุลินทร	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
10. นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
11. นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
12. นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
13. นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
14. นางนาตยา ทฤษฎิคุณ	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
15. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่10
16. นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่11
17. แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่12
18. นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่13

ประธานคณะทำงาน

1. นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
2. นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

คณะทำงาน

1. นางสาวศรัญญา พรมเสนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
2. นางสาวกรรณิการ์ พุกศร นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
3. นายสุขเสริม ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
4. นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
5. นางมณฑา โชคชัยไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
6. นางสาวจุฑาทิพย์ จ้อยจุมพจน์ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
7. นางสาวลำไพ เฮ้าไกร นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
8. นางสาวเบญญาภา สมลักษณ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
9. นางสาวศิวนาถ ไชยกันทา นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
10. นางสาวศิริวรรณ คูเมือง นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
11. นางสาวชลิดา สาโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

12. นางสาวลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
13. นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
14. นางสาวยุวนา ไขว้พันธ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
15. นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
16. นายวิษณุกร นาชัยดูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
17. นายมนัสพงษ์ มาลา นักวิชาการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
18. นายวีระพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
19. นางสาวมัณฑิกา ประชากิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
20. นางสาวชญานันทน์ ขันธะชัย นักจิตวิทยา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
21. นางสาวนาถอนงค์ วันธงไชย นักวิชาการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
22. นางอรัญญา สุริยะจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
23. นายพีระพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
24. นางภัทรานิษฐ์ ทองตันไตรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

25. นายคมชาย สุขยิ่ง	นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
26. นายบุญลือ เพ็ชรรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
27. นางสุริ อุปมนต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
28. นางสาวนูรมานีรี สุติรันดร์	นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
29. นายนิตย์ ทองเพชรศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปราณี เนาวนิตย์	นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
2. นางสาวชญาน์นันท์ ศรีหาบุตร	นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน

สอดส่องมองหา
ใส่ใจรับฟัง
ส่งต่อเชื่อมโยง

